

“Funciona” ya no alcanza

Cómo se construye el argumento económico que hace que un pagador latinoamericano diga que sí.

Nelson J. Alvis Zakzuk
Economista. Universidad de Cartagena (Colombia)
MSc. En Gestión Sanitaria. Universidad Politécnica de Valencia (España)
PhD(c) en Epidemiología. Universidade de São Paulo (Brasil)

Los cinco momentos

01 ¿Por qué es importante hablar de esto hoy?

02 Los conceptos, sin fórmulas

03 Métodos y aplicaciones

04 Con qué evidencia se llena la herramienta

05 Construyo el argumento y siguiente paso

MOMENTO 01

¿Por qué es importante hablar de esto hoy?

Sin este contexto los conceptos son académicos. Con él, son urgentes.

¿Cuántos de ustedes han estado frente a un pagador o un médico administrativo y sintieron que les faltaba el argumento económico?

Levanten la mano.

El presupuesto no crece al ritmo de la necesidad

La necesidad es ilimitada

Envejecimiento, cronicidad y tecnología nueva empujan el gasto todos los años.

El presupuesto no lo es

Ningún sistema de la región financia todo lo que su población necesita.

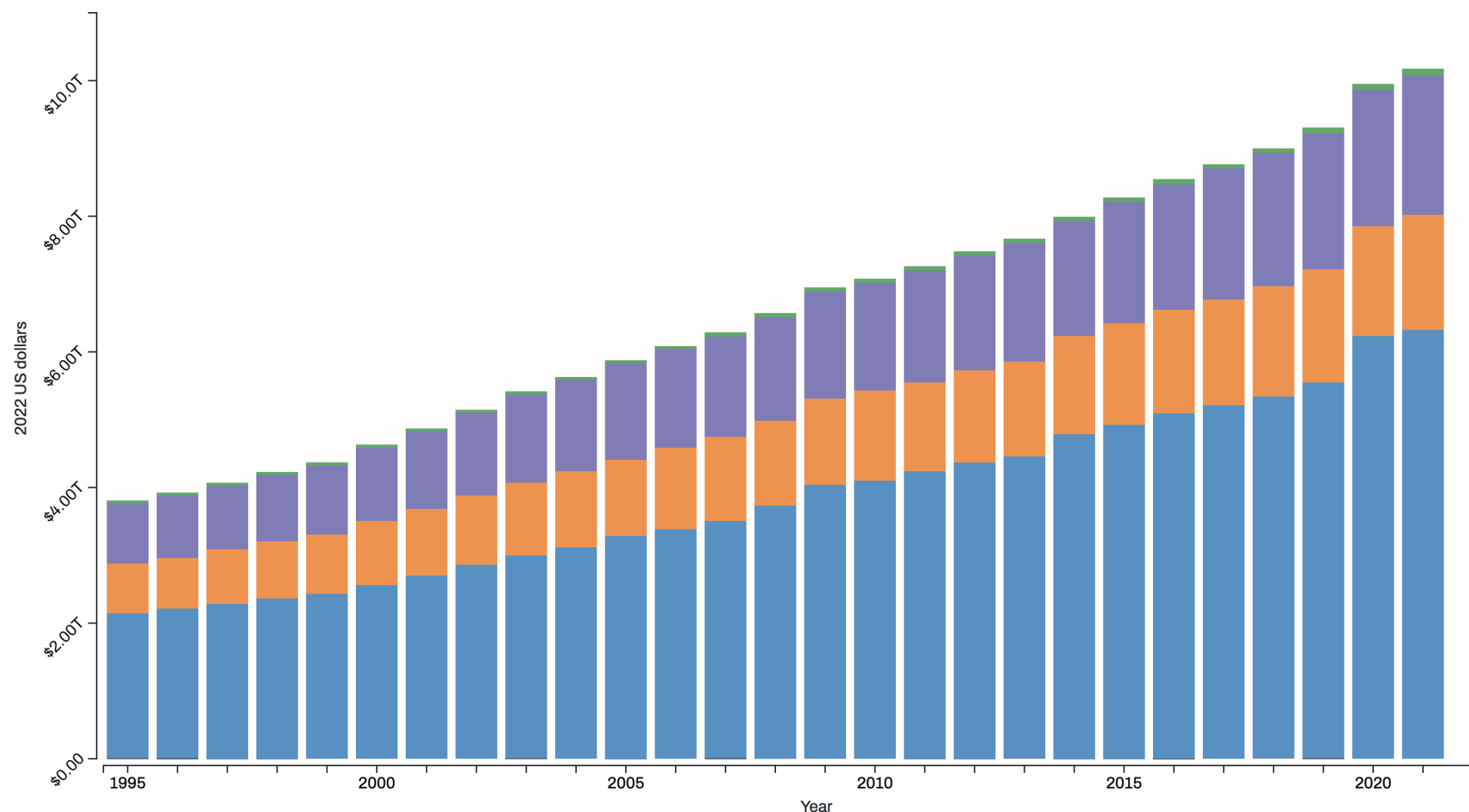
Alguien decide qué entra

Y esa decisión ya no se toma basado solo un criterio clínico.

La farmacoeconomía no es teoría académica. Es la herramienta más concreta que ustedes tienen para posicionar el portafolio en esa decisión.

Y crece más rápido que la economía que lo paga

Global, all-cause total spending, 1995-2021



Gasto mundial en salud por fuente de financiación, 1995–2021 · IHME

10,2 billones

de dólares gastó el mundo en salud en 2021

2,7×

es lo que ese gasto se multiplicó desde 1995

10% del PIB

mundial — y la proporción sigue subiendo

Y no crece igual en todas partes. En los países de ingreso bajo y medio el gasto sanitario aumenta 6% al año; en los de ingreso alto, 4%. América Latina está en el grupo que crece más rápido, y con menos margen fiscal para absorberlo.

El mismo dinero, tres formas de gastarlo

Una aseguradora tiene USD 250.000 para un año y 1.000 pacientes con artrosis de rodilla en estadios II y III. **En las tres opciones gasta exactamente los mismos USD 250.000. Lo que cambia es a cuántos pacientes alcanza y cuántos de ellos mejoran.**

LA OPCIÓN	CUESTA CADA UNO	ALCANZAS A	GASTAS EN TOTAL	MEJORAN
Analgesia multimodal	USD 250	1.000	USD 250.000	180
Viscosuplementación	USD 500	500	USD 250.000	210
Reemplazo de rodilla	USD 5.000	50	USD 250.000	42

La columna del total es igual en las tres filas. Esa es la restricción.

¿Cuál compran?

Cifras hipotéticas construidas para el ejercicio: 250×1.000 , 500×500 y 5.000×50 dan los mismos USD 250.000. Ninguna procede de una fuente publicada.

Elegir una es renunciar a las otras dos

Eso a lo que se renuncia tiene nombre: costo de oportunidad.

LO QUE COMPRARON

Viscosuplementación

210

pacientes mejoran

LO QUE YA NO OCURRE

Analgesia multimodal

180

mejorías que no ocurrirán

LO QUE YA NO OCURRE

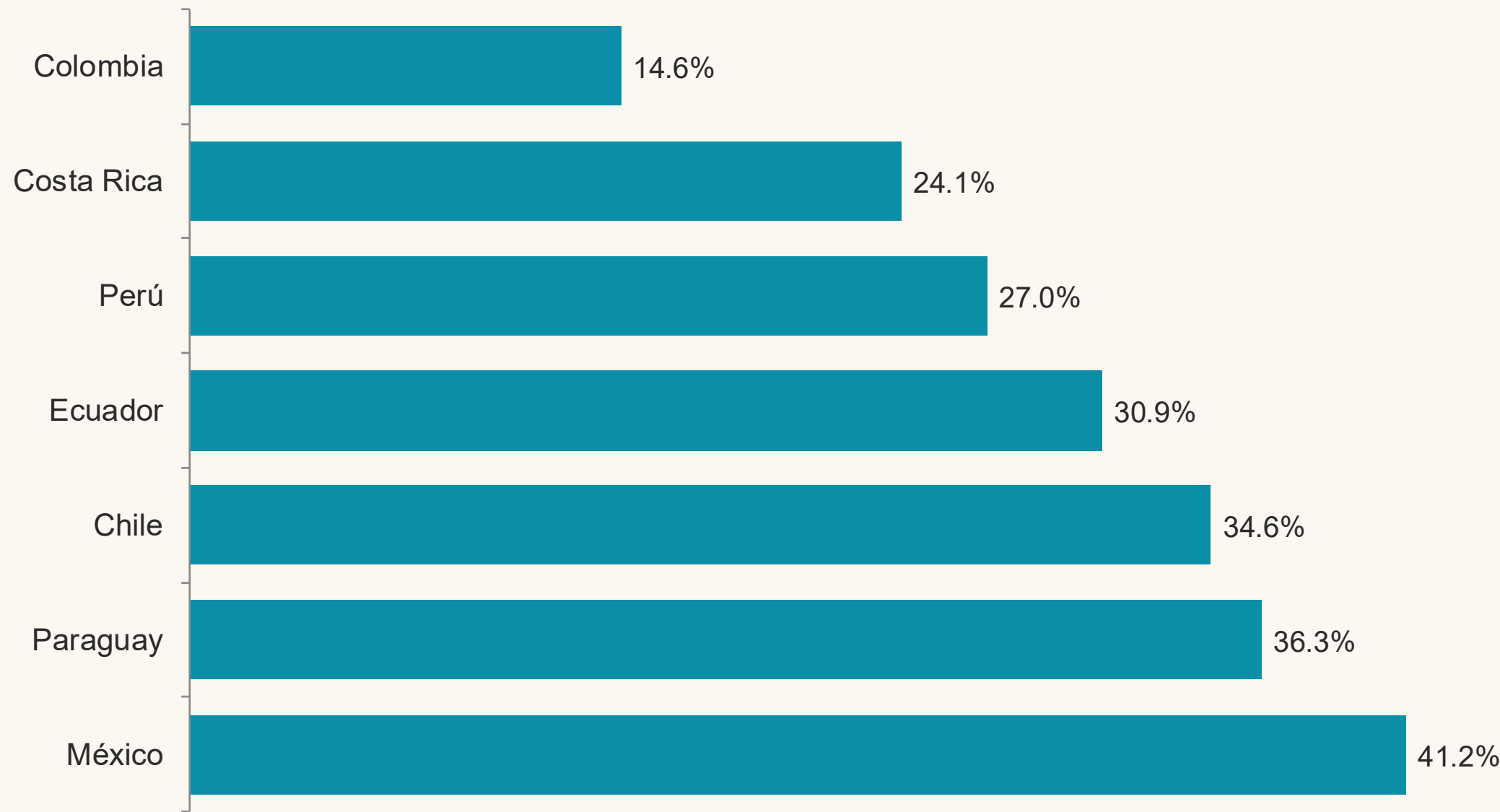
Reemplazo de rodilla

42

rodillas que no se operan

Y ojo: ustedes pelean en dos frentes. Uno, que el sistema le destine el presupuesto a la viscosuplementación y no a la analgesia crónica ni a la cirugía temprana. Dos, que entre los hialuronatos que compiten, entre el suyo. Son dos peleas distintas y no se ganan con la misma evidencia.

Qué se cubre y qué no. El gasto de bolsillo lo dice todo



Lo que esto significa

En Colombia el sistema absorbe casi todo, la pelea es entrar al plan de beneficios.

En México y Paraguay una parte enorme la paga el paciente. Ahí el costo evitado golpea un bolsillo, no un presupuesto.

Un argumento no sirve para los dos.

Fuente: WHO Global Health Expenditure Database, indicador GHED_OOPSCHE_SHA2011, año 2023 (misma serie que Banco Mundial SH.XPD.OOPC.CH.ZS).

Ocho mercados, ocho reglas distintas de acceso

MERCADO	QUIÉN DECIDE Y POR QUÉ INSTRUMENTO	QUÉ EXIGE
México	Consejo de Salubridad General · Compendio Nacional de Insumos	Evaluación económica + impacto presupuestal, ambos obligatorios
Colombia	Ministerio de Salud decide · Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud evalúa	Sin umbral adoptado ni razón de costo-efectividad obligatoria
Perú	IETSI de EsSalud, DIGEMID y el Instituto Nacional de Salud	Petitorios separados; umbral propuesto, no adoptado
Chile	Ministerio de Salud · Garantías Explícitas en Salud y Ley Ricarte Soto	Sin umbral oficial declarado
Costa Rica	Caja Costarricense de Seguro Social · Lista Oficial de Medicamentos	Publica evaluaciones completas de medicamentos
Ecuador	Consejo Nacional de Salud · Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos	Manual de evaluación rápida sin componente económico
Paraguay	Comité Nacional de Farmacoterapia · Lista Nacional de Tecnologías Sanitarias	En construcción, con acompañamiento de OPS
Argentina	Comisión nacional de evaluación (Decreto 344/2023)	No vinculantes; la cobertura la define cada financiador

Ninguno de estos ocho mercados tiene un umbral de costo-efectividad adoptado por norma. El rango de 1 a 3 veces el producto interno bruto per cápita es una convención de investigadores, no una norma nacional.

El mismo dato, tres conversaciones distintas

Acceso / Market Access

Habla con el pagador

Sostenibilidad y retorno. «¿Mi portafolio se puede pagar con los recursos que el asegurador ya tiene? ¿Cuánto le cuesta al sistema no tenerlo?»

Marketing / Producto

Habla con el prescriptor

Costos evitables y resultados. «¿Cómo hago que mi prescriptor gane? No solo con el dato clínico, sino mostrando que no le hace un hueco al sistema.»

MSL / Médica

Habla con el científico del asegurador

Evidencia económica más tranquilidad clínica. «Cada día más MSL van a las aseguradoras. El argumento ya no es solo el dato clínico.»

No basta con demostrar que la tecnología funciona. Hay que demostrar que se puede pagar, y decirlo en el idioma de quien tiene enfrente.

**No van a salir construyendo
un modelo de Markov.**

**Van a salir sabiendo qué tipo de estudio pedir, cómo leerlo,
cómo interpretarlo y cómo usarlo frente a un pagador.**

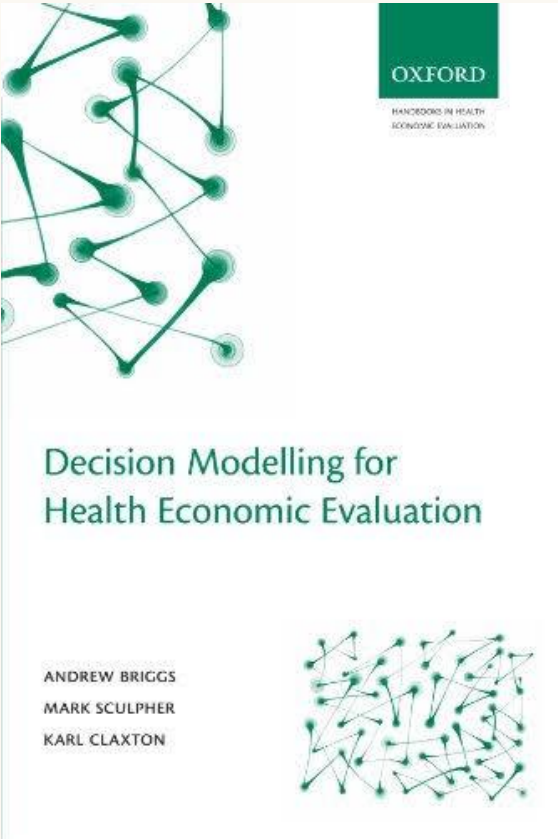
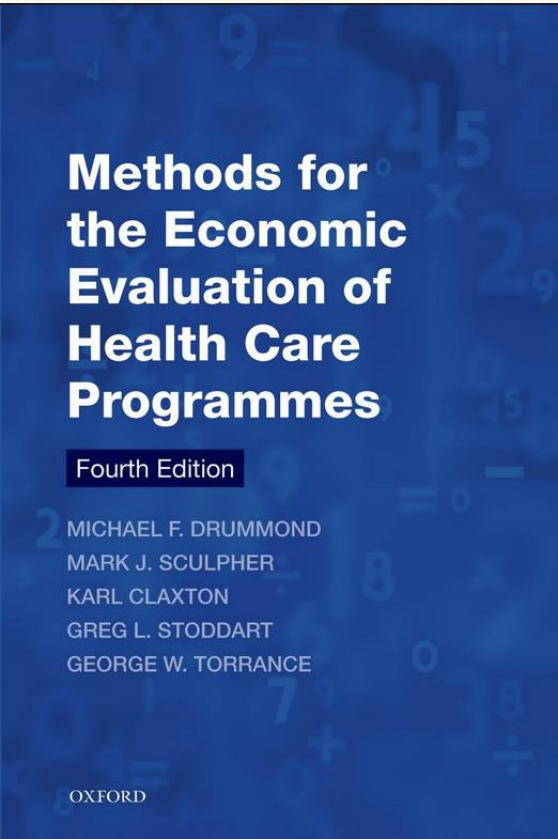
MOMENTO 02

Los conceptos, sin fórmulas

Cada término aterrizado en una decisión concreta del portafolio.

Esto no lo estamos inventando

El marco de la lámina siguiente sale del primer libro. Los cinco tipos de modelo que veremos más adelante, del segundo. Y la literatura publicada de costo-efectividad se cuenta por decenas de miles.





National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Log in



×

Search

[Advanced](#) [Create alert](#) [Create RSS](#) [User Guide](#)

Save

Email

Send to

Sort by:

Best match

Display options 

MY CUSTOM FILTERS
[Edit custom filters](#)

83,991 results

⏪

<

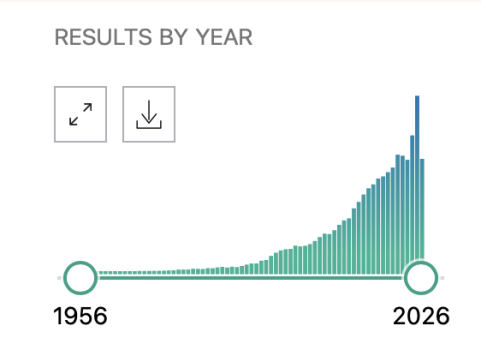
Page

1

of 8,400

>

⏩



83.991 artículos. La curva es la de publicaciones por año desde 1956: casi todo el volumen está en los últimos quince años. Esta disciplina tiene manual, tiene revistas y tiene setenta años, y sus reglas ya están escritas. La pregunta no es si aplicarlas, es cuál aplicar.

Qué es y qué no es una evaluación económica

	MIRA SOLO LAS CONSECUENCIAS	MIRA SOLO LOS COSTOS	MIRA COSTOS Y CONSECUENCIAS
NO compara alternativas	Descripción de resultados	Descripción de costos	Descripción de costo-resultado
SÍ compara alternativas	Evaluación de eficacia o de efectividad	Análisis de costos (aquí vive el impacto presupuestal)	EVALUACIÓN ECONÓMICA COMPLETA minimización · efectividad · utilidad · consecuencia

Por qué importa antes de ver los siguientes métodos. Solo cuatro de caen en la casilla azul. El costo de enfermedad, el análisis de costos con datos reales, el impacto presupuestal y el multicriterio son insumos valiosísimos, pero no son evaluaciones económicas completas. Llevarlos como si lo fueran es la forma más rápida de perder credibilidad en un comité, y decir ustedes primero en qué casilla está su estudio es la forma más rápida de ganarla.

Lo que decimos · lo que oye el pagador

LO QUE DECIMOS	LO QUE OYE EL PAGADOR	LA LECCIÓN
«Es más efectivo»	¿Comparado con qué, en qué paciente y por cuánto tiempo?	<i>El comparador define la respuesta antes que el dato</i>
«Es más seguro»	¿Cuántos eventos evita y cuánto cuesta cada evento?	<i>La seguridad se paga cuando se traduce a costo evitado</i>
«Es más rentable»	¿Retorno cuantificado sobre qué inversión y en qué horizonte?	<i>Un número, un comparador, un horizonte</i>
«Mejora la calidad de vida»	¿Cuánta, medida cómo, y cruza el umbral de relevancia clínica?	<i>Aquí es donde más dossiers se caen</i>
«Tiene evidencia»	¿De qué diseño, de qué población y quién la financió?	<i>La procedencia pesa tanto como el resultado</i>

Bogotá–Cartagena: el ICER en un solo viaje

BUS

USD 40

20 horas de viaje

AVIÓN

USD 130

2 horas de viaje

POR CADA HORA GANADA

USD 5

USD 90 extra ÷ 18 horas ahorradas

Eso es un ICER: el sobreprecio dividido entre lo que ganas. Nada más.

En salud: costo adicional del tratamiento nuevo ÷ salud adicional que produce (AVAC, eventos evitados, años de vida).

El umbral: cuánto vale la hora de quien decide

El estudiante

Su hora vale menos de USD 2. Pagar USD 5 por cada hora que se ahorra es carísimo. Toma el bus.

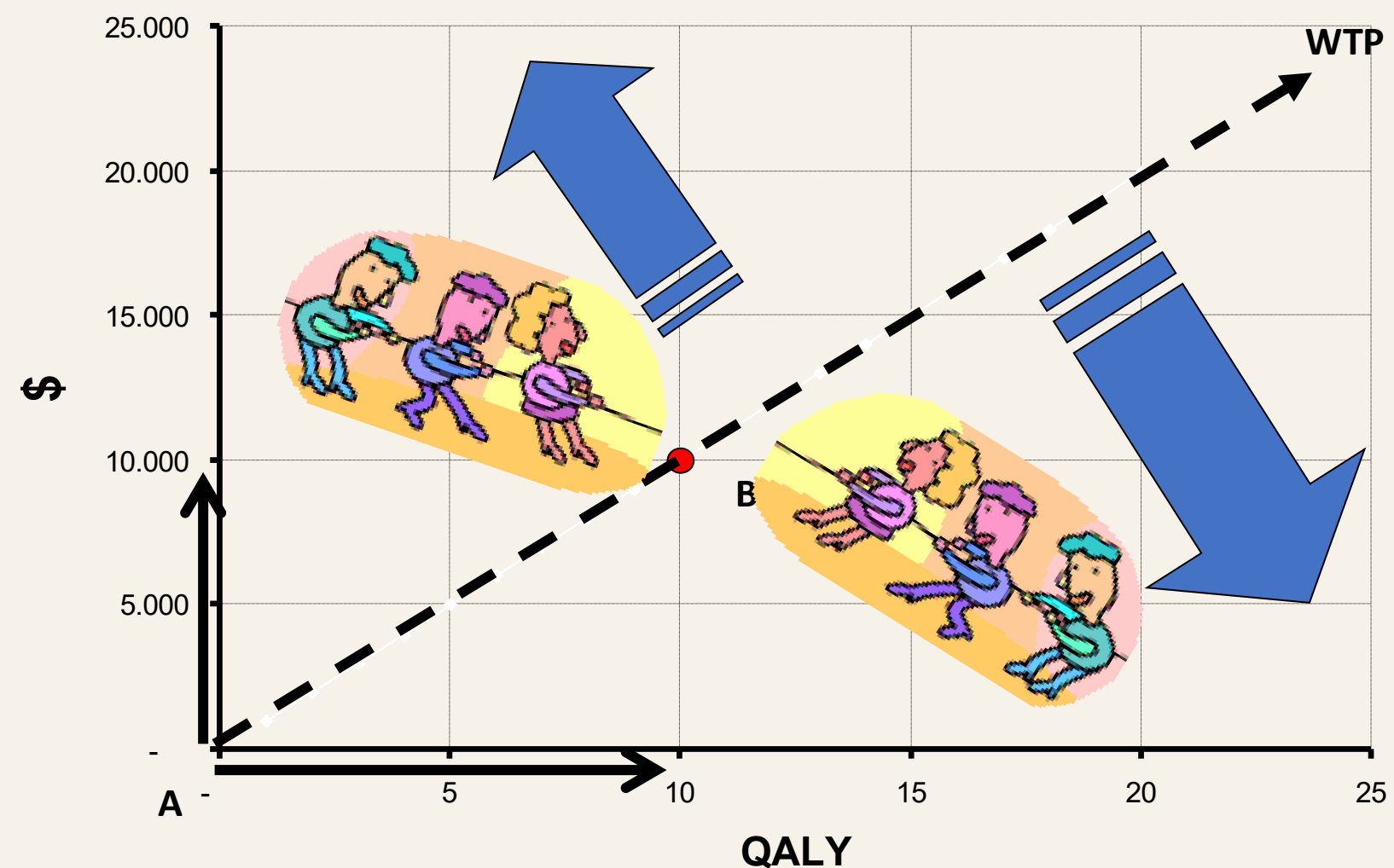
La ejecutiva con junta mañana

Su hora vale USD 80. Pagar USD 5 por cada hora que se ahorra es un regalo. Vuela.

Mismo ICER, decisiones opuestas. El umbral no es una propiedad del producto, es del que decide. En salud se llama disponibilidad a pagar, o willingness to pay. Cuánto está dispuesto a pagar el sistema por un AVAC.

La realidad regional: ningún país de la región ha adoptado un umbral por norma. Colombia tiene la mejor estimación técnica, publicada por Espinosa en 2022 con precios de 2019: USD 5.180,80 por año de vida ganado con calidad y USD 4.487,50 por año de vida perdido. No está adoptada. Equivale al 0,86 y al 0,745 del PIB per cápita: está por debajo de 1 PIB, no en el rango de 1 a 3 de la regla de la OMS. **Cualquier caso construido contra un umbral de 1–3 PIB per cápita es inválido en Colombia.**

El umbral no lo fija un técnico: se tira de él



El punto rojo es el umbral: lo que el sistema acepta pagar por un AVAC. La recta punteada es la disponibilidad a pagar.

Y nadie lo fija solo. La industria tira hacia arriba: le conviene que se acepte pagar más por cada unidad de salud. El pagador y el ministerio tiran hacia abajo: cada peso que sube el umbral desplaza otra cosa del presupuesto. Y las familias tiran desde el gasto de bolsillo, que es exactamente lo que terminan pagando cuando el sistema dice que no.

Por eso ningún país de la región tiene umbral adoptado por norma. No es un vacío técnico: es un equilibrio político que nadie quiere firmar. Y para ustedes eso es una oportunidad, no un obstáculo: donde no hay umbral, la herramienta que decide es el impacto presupuestal.

Cuatro siglas, una línea cada una

ICER

Costo adicional por unidad de salud ganada

Solo significa algo contra un comparador concreto. Sin comparador, un ICER no es un número: es una opinión.

AVAC

Año de vida ajustado por calidad, la salud que se GANA

Cada año de vida se pondera de 0 (muerte) a 1 (salud plena). Más es mejor. Es la moneda de las agencias... y el terreno donde podrían rechazar nuestra molécula

AVAD

Año de vida ajustado por discapacidad, la salud que se PIERDE

Muerte prematura más años vividos con discapacidad. Menos es mejor. Sirve para dimensionar el problema, no para vender el producto.

AIP

Impacto sobre el presupuesto a 3–5 años

La cifra que el pagador se lleva a su comité. La más subestimada por la industria y la más usada por quien decide.

La regla para no confundirse: la Q de quality cuenta hacia arriba, la D de disability cuenta hacia abajo.

Cuatro tipos de costo

Directos médicos

Lo que factura el sistema

La ampolla, la consulta, la infiltración, el analgésico formulado, la artroplastia y su hospitalización.

Directos no médicos

Lo que cuesta llegar al servicio

El transporte a la clínica cinco semanas seguidas, el acompañante que pide permiso, el alojamiento si vive lejos.

Gasto de bolsillo

Lo que paga el paciente de su propio dinero

La cuota moderadora, el antiinflamatorio de mostrador, o la ampolla completa en los mercados donde no hay cobertura.

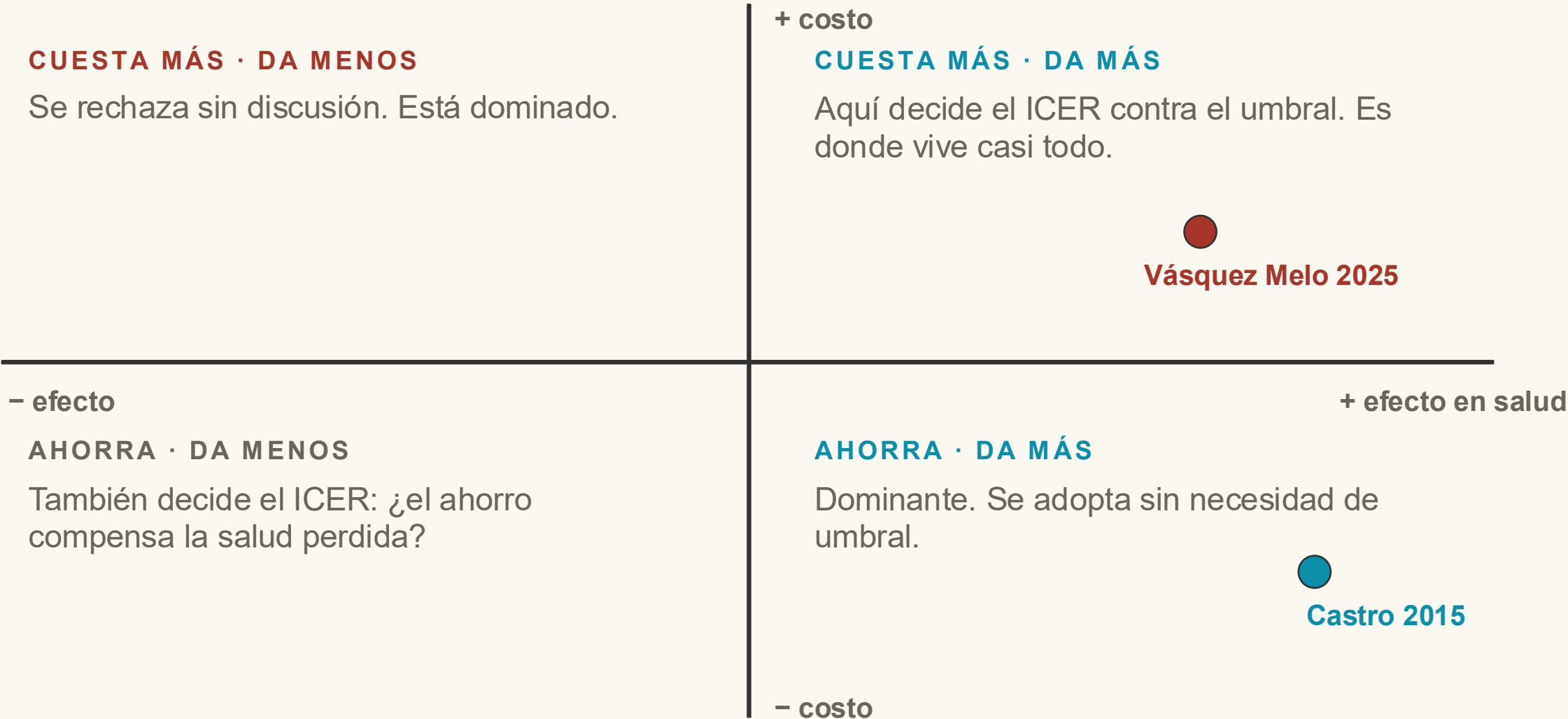
Indirectos

La productividad que se pierde

Los días que no trabajó por el dolor, los que no trabajó por la cirugía, y los que no trabajó su cuidador.

Cuál de los cuatro cuenta lo decide la perspectiva. Perspectiva del pagador: solo los directos médicos. Del sistema de salud: todos los directos. De la sociedad: todos, incluidos los indirectos. **Ampliar la perspectiva casi siempre favorece a la tecnología que evita una cirugía,** y por eso lo primero que pregunta un evaluador es desde perspectiva se analiza. Decláren la perspectiva antes de que se las pidan.

El plano de costo-efectividad



DOS ESTUDIOS COLOMBIANOS,
DOS CUADRANTES

Castro 2015 comparó hylan G-F 20 contra terapia de soporte convencional y le salió dominante: menos costo y más AVAC.

Vásquez Melo 2025 lo comparó contra no viscosuplementar y le salió más caro y más efectivo: USD 45,2 millones y 39.400 años libres de artroplastia, frente a USD 27,3 millones y 4.280.

Mismo tipo de producto, mismo país, cuadrantes distintos. La diferencia no está en la molécula: está en el comparador y en el desenlace que cada equipo eligió.

Castro 2015 es costo-utilidad con AVAC. Vásquez Melo 2025 es costo-consecuencia y su desenlace son años libres de artroplastia, no AVAC: su posición aquí es ilustrativa del signo, no un ICER comparable.

Cinco modelos: cuál pide cada enfermedad

MODELO	EN UNA LÍNEA	CUÁNDO	ATERRIZADO
Árbol de decisión	Caminos posibles con probabilidades, de una sola pasada	Horizonte corto, eventos puntuales	Dropyal: evento gastrointestinal evitado, infiltración, cirugía a 1–2 años
Markov	La enfermedad como estados que el paciente recorre en ciclos	Crónicas de largo plazo	Vilzernet en diabetes tipo 2: control, complicación, muerte
Microsimulación	Un Markov paciente por paciente, con historia individual	Cuando la heterogeneidad importa	Poblaciones con riesgo basal muy distinto entre sí
Supervivencia particionada	Reparte la cohorte según curvas: sin progresión, progresado, muerto	El estándar en oncología	Los oncológicos del portafolio
Transmisión dinámica	Tratar a unos cambia el riesgo de los demás	Infecciosas e inmunización	Fuera del caso de hoy, pero domina en vacunas

La pregunta correcta no es «¿qué modelo me gusta?» sino «¿qué estructura tiene la enfermedad?». Para Dropyal, la respuesta es la más simple de todas.

MOMENTO 03

Siete métodos, siete casos reales

Cada tipo de evaluación económica explicado en una lámina, y en la siguiente un estudio publicado de hialuronato intraarticular con su financiador declarado.

Cuánto cuesta el problema, sin tocar nada

Le pones precio a la enfermedad tal como se atiende hoy. No comparas nada, solo cuentas.

La enfermedad, como se atiende hoy

Todos los pacientes, todos los costos del año



= lo que le cuesta al sistema cada año

Fíjense en lo que no hay: no hay una segunda caja. Sin comparador no hay evaluación económica completa.

Se usa cuando... quieres dimensionar el tamaño del problema y abrir la conversación con una cifra que impresione. Es el punto de partida, no el argumento.

Cuánto cuesta el problema hoy

Responde: ¿Qué le cuesta hoy al sistema atender esta enfermedad, sin cambiar nada?

EL PAPER

Costo directo de la atención médica en pacientes con gonartrosis

Villarreal-Ríos E, et al. Reumatología Clínica 2019;15(5):277-281 · Instituto Mexicano del Seguro Social

Comparador	Ninguno. Describe la práctica actual
Desenlace	Costo directo por paciente al año
Financiador	No especificado, sin conflictos declarados

RESULTADO

€108,87 por paciente al año

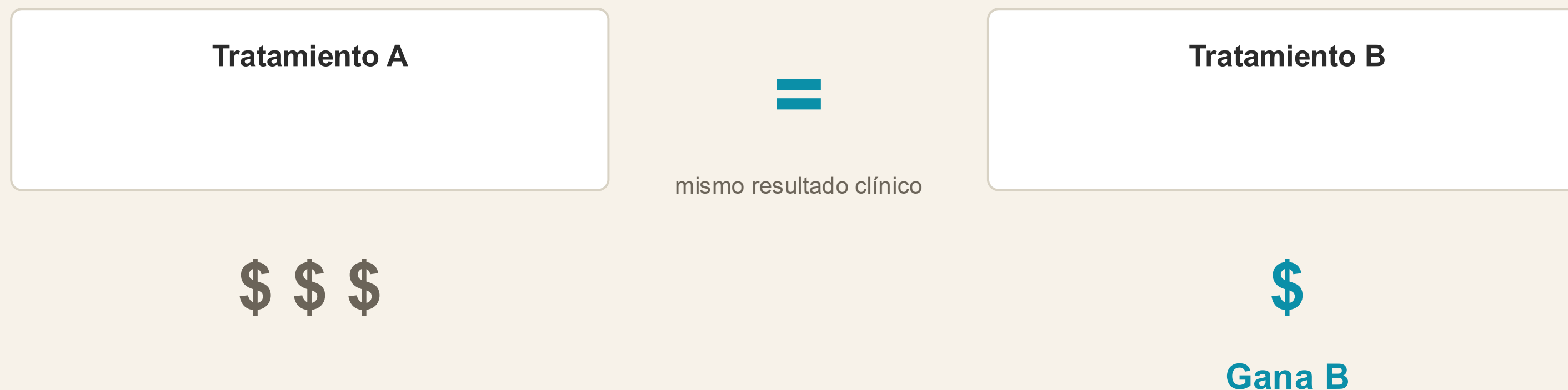
Proyectado a 10,9 millones de pacientes: 4,48% del gasto en salud de México

LA LECCIÓN

Sirve para dimensionar el problema y abrir la conversación, no para defender un producto. Es un insumo, no una evaluación económica completa.

Si funcionan igual, gana el más barato

Pones dos tratamientos lado a lado, aceptas que hacen lo mismo, y comparas solo el precio.



Toda la discusión se traslada al precio. Por eso es la herramienta más limpia y la que menos evidencia nueva exige.

Se usa cuando... puedes sostener con evidencia que las dos alternativas dan el mismo resultado clínico. Si esa equivalencia no se sostiene, todo el análisis se cae.

Cuando ya asumiste que funcionan igual

Responde: Si dos alternativas tienen la misma eficacia, ¿cuál cuesta menos al sistema?

EL PAPER

Análisis de minimización de costos e impacto presupuestal de la viscosuplementación

Castañeda-Cardona C, Gil-Rojas Y. Rev Colomb Reumatol 2024;31(2):150-158 · El Salvador y Panamá

Comparador	Hylan G-F 20 frente a hialuronato de sodio de bajo peso molecular
Desenlace	Costo anual por paciente
Financiador	Sanofi

RESULTADO

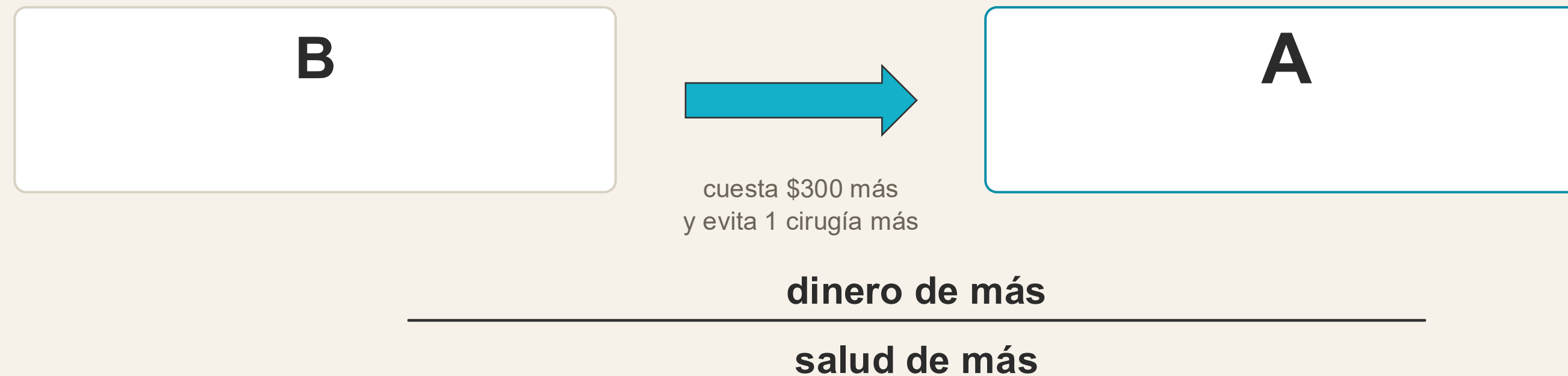
Ahorro de USD 202,2 (39%) en El Salvador y USD 567,7 (58%) en Panamá, a favor del hylan

LA LECCIÓN

Según lo que encontramos, es la única evaluación económica de Centroamérica, la publicó el competidor, y el comparador que sale caro es justamente el perfil de Dropyal. La herramienta estaba disponible: la usó el otro, primero.

Cuánto cuesta cada unidad de salud que ganas

Lo nuevo cuesta más y da más. Divides el dinero de más entre la salud de más, y comparas ese cociente contra lo que el sistema está dispuesto a pagar.



= el cociente que se compara contra el umbral

Si la salud se mide en cirugías o eventos evitados se llama costo-efectividad. Si se mide en años de vida ajustados por calidad, costo-utilidad. Es el mismo cálculo.

Se usa cuando... tu producto es mejor pero más caro, y el que decide tiene un umbral o al menos una referencia de cuánto está dispuesto a pagar.

Costo por año de vida con calidad

Responde: ¿Cuánto cuesta ganar un año de vida ajustado por calidad, frente al umbral del país?

EL PAPER

Cost-effectiveness Analysis of Viscosupplementation versus Conventional Supportive Therapy

Castro JC, Daza AM, Misas JD. Value Health Reg Issues 2015;8:56-61 · Colombia

Comparador	Hylan G-F 20 frente a terapia de soporte convencional
Desenlace	Año de vida ajustado por calidad, por simulación de eventos discretos
Financiador	Sanofi

RESULTADO
DOMINANTE

Más efectivo y menos costoso que la terapia convencional

LA LECCIÓN

Es la única evaluación colombiana con años de vida ajustados por calidad. Pero tiene precios de 2012

Pones todo sobre la mesa y no lo resumes

Muestras cada resultado por separado, con su costo al lado, y dejas que el que decide pondere. No hay un número final.

	Lo de siempre	Lo nuevo
Dolor a 6 meses	poca mejoría	mejoría clara
Cirugías evitadas	ninguna	varias
Costo por paciente	bajo	más alto

Nadie suma esta tabla. Ese es el punto: cada quien pesa lo que le importa.

Se usa cuando... los desenlaces no se pueden meter en una sola unidad, o cuando no hay umbral contra el cual comparar un cociente. Es honesto y es el más fácil de leer.

Cuando no se puede resumir en un solo número

Responde: ¿Qué pasa con cada desenlace por separado, sin forzarlos a una sola cifra?

EL PAPER

Clinical and economic impact analysis of viscosupplementation with hylan G-F 20

Vásquez Melo EC, Lasalvia P, et al. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2025;25(4):527-534 · Colombia

Comparador Hylan G-F 20 frente a otros hialuronatos frente a no viscosuplementar

Desenlace Años libres de artroplastia, a 5 años

Financiador No declarado de forma accesible

RESULTADO

39.400 frente a 30.741 frente a 4.280 años libres de cirugía

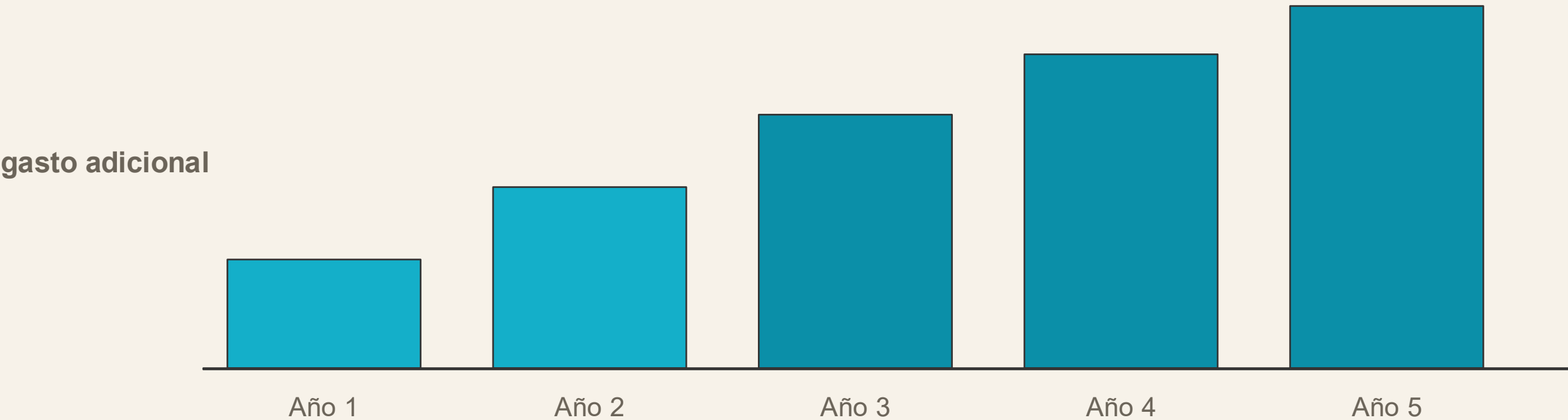
Costo: USD 45,2 M · 50,2 M · 27,3 M

LA LECCIÓN

No calcula un cociente, así que no se puede medir contra un umbral. A cambio habla el idioma del pagador: cirugías que no ocurren.

¿Alcanza la plata?

No preguntas si vale la pena. Preguntas cuánto más va a gastar el pagador cada año si dice que sí, y si eso le cabe en el presupuesto.



El pagador no quiere un cociente. Quiere saber cuánto le va a costar en pesos, en los próximos tres a cinco años.

Se usa cuando... el que decide no tiene umbral adoptado, que es el caso de todos los mercados de la región. Es la herramienta que de verdad se lleva a un comité.

El único de los siete sin estudio publicado en la región

QUÉ SE NECESITA

Población elegible del asegurador, porcentaje que recibiría el tratamiento, precio unitario, y el costo de lo que se desplaza.

QUÉ FALTA HOY

El costo unitario de una artroplastia total de rodilla no está publicado en Colombia, México ni Perú. Sin ese dato el modelo queda cojo.

POR QUÉ IMPORTA

Es la herramienta que un pagador sin umbral adoptado lleva a su comité. En esta región, eso son todos los pagadores.

Según lo que encontramos, existe poca evidencia de AIPs de hialuronato intraarticular publicados y citables en América Latina. El que existe es el análisis colombiano del propio equipo de Adium, que se muestra en el bloque que sigue.

Y esa es exactamente la oportunidad. El primero que publique un AIP de esta tecnología define el marco con el que van a evaluar a todos los demás. Ese trabajo ya empezó, lo hizo el equipo de Adium, y lo van a ver posteriormente.

Dónde se va la plata de verdad

En vez de suponer, miras los registros de lo que de verdad se facturó a miles de pacientes y cuentas en qué se fue el dinero.



Todo el costo de tratar a un paciente con artrosis de rodilla, repartido según lo que se facturó de verdad.

El argumento no es que el producto sea barato. Es que lo caro es la cirugía.

Se usa cuando... quieres mostrar que tu producto es una fracción mínima del costo total, y que lo caro está en otra parte. Reencuadra la discusión de precio.

Dónde se va la plata, según los registros

Responde: En la práctica real, ¿cuánto pesa cada componente del costo de tratar a estos pacientes?

EL PAPER

Knee Osteoarthritis Treatment Costs in the Medicare Patient Population

Malanga G, Niazi F, Kidd VD, et al. Am Health Drug Benefits 2020;13(4):144-153 · 275.256 pacientes

Comparador	Con hialuronato frente a sin inyección
Desenlace	Costo observado y tiempo hasta la artroplastia
Financiador	Ferring Pharmaceuticals

RESULTADO

El hialuronato es el 1,8% del costo total.
La cirugía, el 76,6%.

Mediana hasta la artroplastia: 16,4 frente a 5,7 meses

LA LECCIÓN

El argumento más potente no es que el producto sea barato: es que lo caro es la cirugía. Reencuadra la discusión de precio.

Cuando el precio no es lo único que pesa

Le preguntas al que decide qué criterios le importan y cuánto pesa cada uno. Después puntúas cada alternativa contra esa lista.



Pesos reales medidos en 178 participantes. El precio del tratamiento pesa la mitad que la duración del efecto.

Se usa cuando... no hay umbral de costo-efectividad, hay varios criterios en juego y quieres entender qué mueve de verdad la decisión.

Cuando el costo es solo uno de ocho criterios

Responde: ¿Qué pesa realmente en la decisión, cuando no hay umbral de costo-efectividad?

EL PAPER

Stakeholders' preferences for osteoarthritis interventions in health services

Chua J, Hansen P, Briggs AM, et al. Osteoarthr Cartil Open 2020;2(4):100110 · 178 participantes, Nueva Zelanda

Comparador Intervenciones de osteoartritis entre sí, en ocho criterios

Desenlace Puntaje ponderado por preferencias

Financiador No verificado

RESULTADO

El costo pesa 6,6%.

La duración del efecto, 13,2%. El riesgo de daño grave, 12,8%. La calidad de la evidencia, 17,7%

LA LECCIÓN

En un marco multicriterio, el precio de la ampolla pesa la mitad que la duración del efecto. Cambiar de marco cambia el terreno de juego.

Seis estudios. En algunos se sabe quién pagó, en otros no...

Sanofi

Minimización de costos en El Salvador y Panamá

Gana el producto del financiador. El hialuronato de bajo peso molecular es el comparador caro.

Ferring

Análisis de costos con datos de facturación

Gana el mensaje de que el medicamento es apenas el 1,8% del costo total.

Sin financiador accesible

Las dos evaluaciones colombianas y el multicriterio

No se puede saber quién los pagó. Eso también es información, y un evaluador la va a buscar.

Antes de creerle a un resultado, hay que saber quién pagó la pregunta.

Qué herramienta pide cada situación

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | ¿Tu comparador es placebo o «no tratamiento»? | Sí → no hagas costo-utilidad. Perdiste antes de empezar. |
| 2 | ¿Puedes sostener equivalencia clínica? | Sí, y el comparador es más caro → costo-minimización. |
| 3 | ¿Tu ventaja está en el alivio del dolor? | Sí → no uses AVAC. Es el terreno donde te rechazan. |
| 4 | ¿El decisor exige evaluación económica formal? | Sí → costo-efectividad con desenlace natural + AIP. No → costo-consecuencia + AIP. |
| 5 | ¿Tu argumento es de volumen y presupuesto? | Siempre → impacto presupuestal. Es tu terreno más fuerte. |

El orden importa más que las respuestas. Obliga a decidir el comparador ANTES que la herramienta.

MOMENTO 04

Con qué evidencia se llena el tipo de análisis que selecciono

Ya saben qué herramienta pedir. Ahora, qué tan fuerte es la evidencia que tienen para llenarlo, cuál es la mejor cita que existe, y cómo verificar una en noventa segundos.

¿Cuánto alivia el dolor? Depende de a quién le preguntas

Pereira, revista BMJ, 2022

Se quedó solo con los 24 ensayos grandes. Sin industria detrás.



0,08

Richette, revista RMD Open, 2015

Se quedó solo con los estudios de bajo riesgo de sesgo.



0,21

Bannuru, Annals of Internal Medicine, 2015

Incluyó todos los estudios. Lo pagó la agencia pública de investigación de Estados Unidos.



0,63

0,37: lo mínimo que un paciente nota

Qué es ese número. Es cuánto mejora el dolor frente a una inyección de placebo, en una escala que permite juntar estudios distintos. Se lee así: 0,2 es un efecto pequeño, 0,5 moderado y 0,8 grande. Tres equipos, la misma pregunta, respuestas que se diferencian por ocho veces: lo único que cambió fue a qué estudios se restringieron. Sobre esa ganancia se calculan los años de vida con calidad.

El contraargumento no es discutir el 0,08 sino el comparador: Saltzman 2017 mostró que los brazos de solución salina de 13 ensayos mejoraron 16,62 mm en la escala visual de dolor a los seis meses, por encima del mínimo perceptible. El placebo de estos ensayos no es inerte, y ese dato es independiente.

LATINVISCO 2026

Consenso de 25 especialistas de 15 países latinoamericanos sobre viscosuplementación en artrosis de rodilla. Uno de los autores es colombiano.

POR QUÉ VALE

Nadie se la pagó

Ningún fabricante la financió y sus autores no declaran conflictos de interés. Es la única fuente favorable de esta clase que no salió de la industria. Ese es su verdadero valor.

LO QUE DICE A FAVOR

Recomienda usarla

En artrosis de rodilla leve, moderada y avanzada recomienda la viscosuplementación por su efectividad, y lo respalda con evidencia de alta calidad.

LA LETRA PEQUEÑA

Hay que leerla completa

Cuando afirma que tiene mejor relación costo-beneficio que el corticoide, lo respalda con evidencia de baja calidad. Y atribuye la ventaja económica al hialuronato de alto peso molecular en dosis única.

Es la cita más fuerte que tienen. Y si el evaluador la lee completa, le contradice el eje del peso molecular. Mejor decirlo ustedes primero.

Hamdan PC, et al. LatinVisco: a Latin American expert consensus on viscosupplementation for knee osteoarthritis. Complementary Therapies in Medicine 2026;99:103385. Dónde encaja: OARSI, PANLAR, ESCEO e IMSS están a favor; el Colegio Americano de Reumatología, la agencia británica NICE y la brasileña en contra. El «no» chileno es condicional y con evidencia muy débil.

Comprobar una cita toma noventa segundos

1	¿El DOI resuelve?	Péguenlo en el navegador. Si no abre, revisen antes de concluir que no existe. Es la prueba de treinta segundos.
2	¿Buscaron con todos los términos?	Buscar solo por «hyaluronic acid» pierde toda la literatura publicada como «viscosupplementation» o «viscosuplementación». Así se me escaparon tres citas reales preparando este taller.
3	¿El país es el que dicen?	Una revista colombiana no significa un estudio colombiano.
4	¿Quién lo financió?	Está en la última página. Si lo pagó el competidor, el resultado apunta a otro lado. Y si no lo pagó nadie, dígalo fuerte.
5	¿Las cifras comparan lo mismo?	Mediana contra mediana, grupo entero contra grupo entero. Nunca el total de uno contra el mejor subgrupo del otro.

Si ustedes no lo verifican, lo verifica el evaluador — delante de todo su comité.

MOMENTO 05

Construyo el argumento

A quién le hablo, con qué moneda de cambio, y con qué evidencia lo respaldo.

Armada con lo que sí existe

SÓLIDO CON MATICES

Evitabilidad

Altman 2015, bien citado

Retraso de la artroplastia, con sus límites declarados de frente. La síntesis independiente de Berkani 2022 estima 9,8 meses.

LEVANTABLE YA

Costo evitado

El precio de la artroplastia local

Un dato que cada país puede levantar esta semana. No es una afirmación de eficacia: es lo que está en juego.

RECIÉN CONSTRUIDO

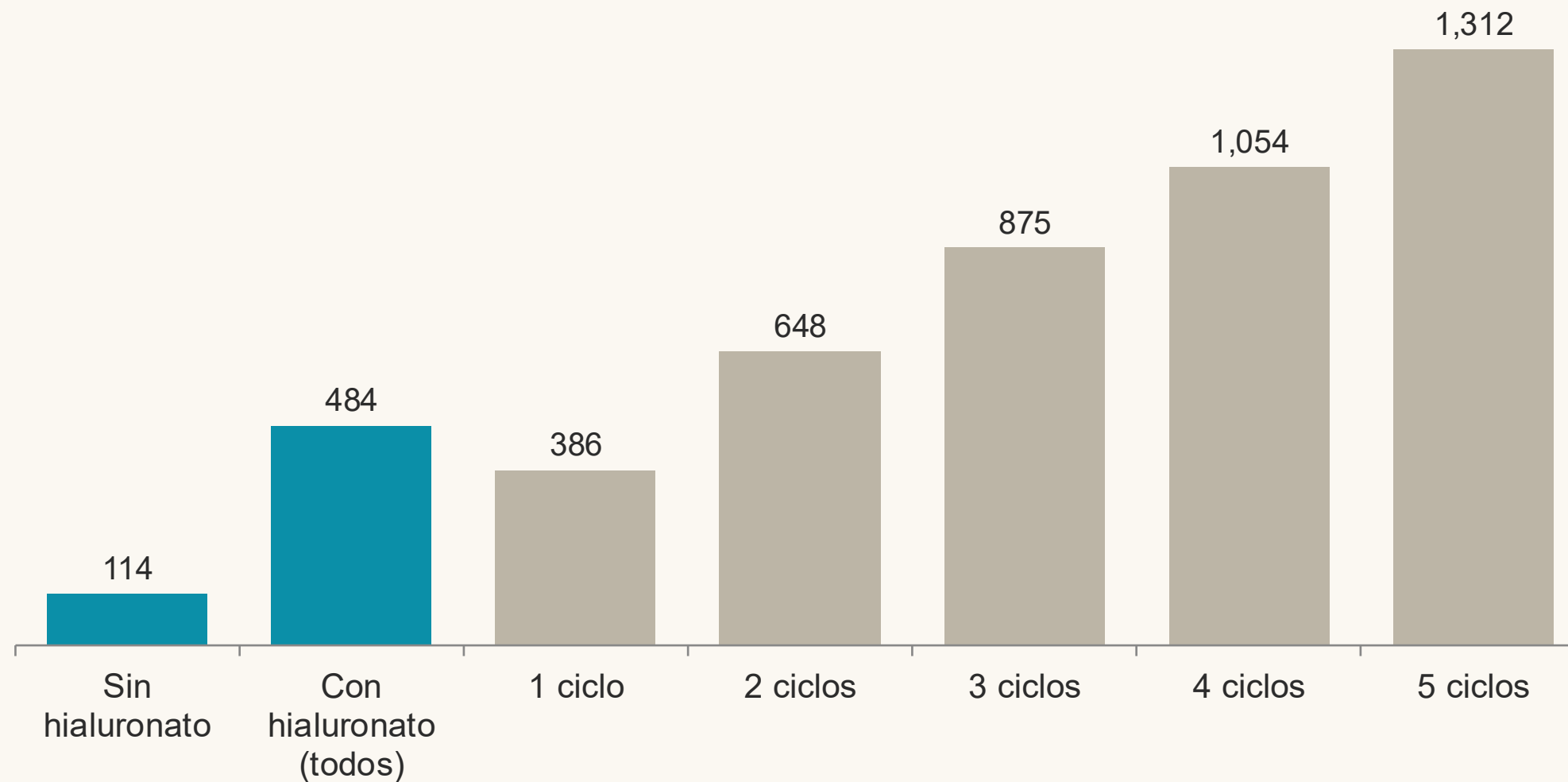
Impacto presupuestal

Análisis colombiano, presentado como póster en ISPOR

La herramienta que un pagador sin umbral adoptado lleva a su comité. Ya existe para Colombia, construida por el equipo de Adium, y la van a ver en el bloque que sigue.

Los tres los tienen hoy. El tercero, el que de verdad decide si entran o no, acaba de hacerse, y es con el que arranca el bloque práctico.

Altman 2015: el dato del retraso de la cirugía



Cómo se dice

«Mediana de 114 días sin hialuronato frente a 484 con hialuronato, con gradiente dosis-respuesta hasta 1.312 días a los cinco ciclos.»

Y se declara antes de que pregunten:

cohorte de 182.022 pacientes, retrospectiva sobre reclamaciones, todos llegaron a cirugía, patrocinio de Seikagaku y Bioventus.

Declarar la debilidad primero es lo que convierte un dato discutible en un argumento que sobrevive.

¿Con qué tipo de decisor vas a hablar?

El argumento correcto depende de cómo razona la persona que tienes enfrente.

Pagador orientado a valor

Mira el valor clínico y económico antes que el precio. Aseguradora, seguridad social o entidad que exige evidencia antes de comprometerse. Su riesgo es aprobar algo que después le cuestionen.

Qué le llevo: Costo por año de vida ganado con calidad (AVAC) · eventos evitados · calidad de la evidencia

Decisor financiero

Compra mirando el presupuesto antes que el resultado clínico. Necesita un número que pueda llevar a una junta, en moneda local y con horizonte claro.

Qué le llevo: Análisis de impacto presupuestal · costo unitario · techo de gasto

Clínico prescriptor

Decide por eficacia y seguridad. No firma la compra, pero define lo que se usa. El argumento económico le llega como extensión del criterio clínico, nunca como reemplazo.

Qué le llevo: Eficacia demostrada · perfil de seguridad · consenso de expertos

Clínico con rol administrativo

Médico sentado en comités de farmacia o dirección médica. Responde ante sus pares y ante el financiero a la vez. El error más común es llegarle con uno solo de los dos argumentos.

Qué le llevo: Resultado clínico más costo evitado · un argumento que aguante en comité

El dato no cambia. Cambia la moneda en que se convierte.

Ya saben qué herramienta pedir y cómo comprobar la evidencia que lo llena.

Y lo que sigue no es un ejercicio hipotético. El análisis de impacto presupuestal de esta tecnología ya existe, lo construyó el equipo de Adium, y se presenta ahora.
